



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA TAHUNAN
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3, Mondoroko, Singosari - Malang

Telp. 0341 - 458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

**LAPORAN KINERJA TAHUNAN RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2025****BAB I
PENDAHULUAN****1.1. Umum/Latar belakang**

Status gizi yang baik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan kesehatan yang pada dasarnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Anak balita, anak usia sekolah, dan ibu hamil merupakan kelompok rawan gizi yang sangat perlu mendapat perhatian khusus karena dampak negatif yang ditimbulkan apabila menderita kekurangan gizi. Stunting, merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis menjadi isu serius di Indonesia saat ini dengan angka prevalensi mencapai 19,8%. Prevalensi balita stunting dan wasting di RS. Prima Husada Malang tahun 2023 sebanyak 6 pasien, tahun 2024 sebanyak 6 pasien, dan pada tahun 2025 sebanyak 9 pasien per September.

Salah satu faktor utama penyebab tingginya angka stunting di Indonesia adalah kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan primer dan konsumsi gizi yang memadai, terutama pada keluarga dengan ekonomi rendah. Kekurangan asupan gizi pada masa kehamilan dan 1.000 hari pertama kehidupan anak dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak yang sifatnya irreversible. Selain itu, kurangnya edukasi tentang pola makan yang seimbang, pentingnya menyusui eksklusif, serta pola asuh juga berperan penting dalam memperburuk masalah stunting ini.

Dampak dari tingginya angka stunting sangatlah merugikan. Anak stunting pada akhirnya dapat menghambat potensi mereka untuk mencapai masa depan yang produktif. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki hambatan pada kemampuan belajar, pada pertumbuhan fisik dan kesehatan, yang pada akhirnya dapat menghambat potensi mereka untuk mencapai masa depan yang produktif.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta dan lembaga non-pemerintah lainnya. Upaya tersebut meliputi perbaikan akses terhadap makanan bergizi, peningkatan pendidikan gizi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, serta kampanye edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik untuk perkembangan anak. Selain itu, investasi dalam infrastruktur kesehatan dan sanitasi juga penting guna menjamin lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak secara optimal.

RS. Prima Husada Malang selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan meningkatkan kualitas dalam melayani pasien stunting dan wasting. Oleh karena itu, perlu adanya program kerja tahunan dan pelaporannya setiap tahunnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan stunting dan wasting dan pengawasan dalam program yang akan diselenggarakan.

1.2. Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan Stunting dan wasting harus berdasarkan peraturan dan undang – undang yang berlaku, diantaranya:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 TAHUN 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/MENKES/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

1.3. Tujuan

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan stunting dan wasting secara optimal sesuai visi dan misi Rumah Sakit.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Terselenggaranya pelayanan stunting dan wasting yang bermutu
2. Tersedianya sumber daya manusia tim stunting dan wasting yang profesional dan berkualitas.
3. Tersedianya sarana, prasarana yang memadai untuk pelayanan stunting dan wasting.



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Menjadi Rumah Sakit Berkualitas Prima Pilihan Seluruh Lapisan Masyarakat

2.2. Misi

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

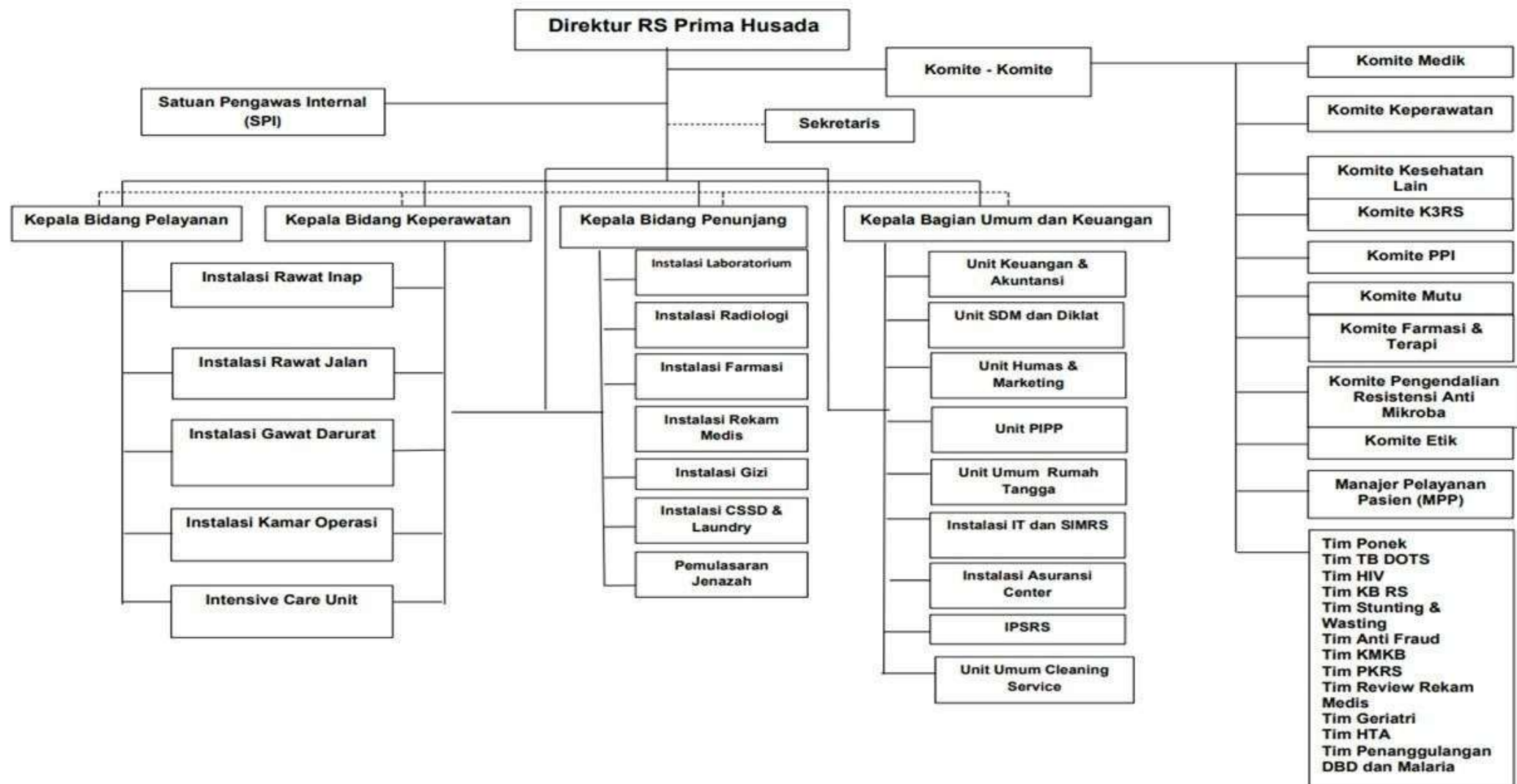
2.3. Motto

Sahabat Menuju Sehat

2.4. 7 Nilai Budi Utama

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5. SOTK



SOTK STUNTING DAN WASTING



BAB III. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

1.1 SDM :

1.1.1 Ketenagaan (distribusi tenaga, kualifikasi dan kebutuhan)

Tabel 1.1 Jumlah SDM Tim Penurunan Prevalensi stunting dan wasting Tahun 2025

Jabatan	Jumlah SDM												
	Standar	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Ketua Tim Stunting dan wasting	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sekretaris program stunting dan wasting	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Anggota Tim Stunting Dan Wasting	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Tabel 1.2 Kualifikasi SDM Tim S&W RSPHM 2025

Jabatan	Kualifikasi	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Ketua Tim Stunting dan wasting	Dokter spesialis Anak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sekretaris program stunting dan wasting	D4 Gizi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Petugas Gizi	S1 Gizi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Perawat IRJ A Anak	D3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Perawat IRNA Anak	D3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Perawat Perinatologi	S1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Apoteker	S1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Analisis :

- . Jumlah tim stunting dan wasting keseluruhan berjumlah 8 orang. Terdiri dari 1 ketua, 1 sekretaris dan 7 anggota.
- . Seluruh tim stunting dan wasting memiliki SIK, SIP, dan STR yang masih berlaku
- . Tim Penurunan prevalensi stunting dan wasting secara keseluruhan sudah memiliki SIP, STR maupun SIK yang masih berlaku.

Rencana Tindak Lanjut :

- . Koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten malang untuk mengembangkan pelayanan serta melakukan pelatihan eksternal terkait program penurunan prevalensi stunting dan wasting.

1.1.2 Orientasi

Tabel 3.1.2 Orientasi Tim Stunting dan Wasting Tahun 2025

No	Nama Peserta	Tanggal Masuk	Pembelajaran Yang diterima	Hasil Evaluasi orientasi Khusus Stunting Dan Wasting								
				Pengetahuan regulasi	Praktek Keterampilan	7 nilai budi utama/						
						J	T	V	D	K	A	P
1	Chandrawati Mustikasari	1 Maret 2025	• Pengertian Prognas • Pemberian pengetahuan manajemen stunting dan wasting • Pemberian kewenangan dalam menjalankan sekretaris tim stunting dan wasting	v	v	v	V	v	v	v	v	V
2	Nafisah Ulfa	15 Mei 2025	• Pengertian Prognas • Pemberian pengetahuan manajemen stunting dan wasting • Pemberiang wewenang dan tanggung jawab sebagai tim stunting	v	v	v	V	v	v	v	v	V
3	Nuraini Radika Rifqi, S. Kep., Ns	23 Oktober 2025	• Pengertian Prognas • Pemberian pengetahuan manajemen stunting dan wasting • Pemberiang wewenang dan tanggung jawab sebagai tim stunting	v	v	v	V	v	v	v	v	V

1.1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Tabel 3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tim Stunting dan Wasting 2025

NO	Tema DIKLAT /WS/SEM/WB	Jenis Diklat	JUMLAH PESERTA		TGL Pelak sanaan	Hasil evaluasi dalam kinerja sehari-hari
			Hadir	Tidak Hadir		
1.	Diklat Stunting dan Wasting “Manajemen	Interna l	29	13	24 Oktober 2025	Staf mampu melakukan dalam sistem penyelenggaraan manajemen stunting

	Stunting dan Wasting”					dan wasting. Sejak pasien datang di IGD hingga pasien KRS
2.	Diklat Stunting dan Wasting “Stunting dan Wasting”	Interna I	29	13	24 Oktober 2025	Staf mampu menjelaskan apa itu stunting dan wasting. Dan bisa menentukan pasien stunting dan wasting dari fisik dan klinis.

3.1.4. Evaluasi Kinerja Staf Tabel 3.1.4 Evaluasi Kinerja Tim Stunting dan Wasting RSPHM Tahun 2025

Tabel 3.1.4 Evaluasi Kinerja Tim Stunting dan Wasting RSPHM Tahun 2025

NO	Nama	Semester 1	Semester 2
1	dr. Fiona Paramitha Sp. A	- Tanggap dan cekatan dalam pemeriksaan pasien - Mampu mengambil keputusan saat menemui masalah - Mampu memberikan Tindakan dan terapi awal sesuai kebutuhan pasien	- Tanggap dan cekatan dalam pemeriksaan pasien - Mampu mengambil keputusan saat menemui masalah - Mampu memberikan Tindakan dan terapi awal sesuai kebutuhan pasien
2	Chandrawati Mustikasari, S. Tr. Gz	- Tanggap dan cekatan dalam melakukan manajemen stunting dan wasting - Mampu mengambil keputusan saat menemui masalah - Mampu memberikan Tindakan dan terapi awal pasien stunting dan wasting	- Tanggap dan cekatan dalam melakukan manajemen stunting dan wasting - Mampu mengambil keputusan saat menemui masalah - Mampu memberikan Tindakan dan terapi awal pasien stunting dan wasting
3	Sistha Gea Aprillia, Amd. Kep	- Tanggap dan cekatan dalam melakukan manajemen stunting dan wasting - Mampu mengambil keputusan saat menemui masalah	- Tanggap dan cekatan dalam melakukan manajemen stunting dan wasting - Mampu mengambil keputusan saat menemui masalah
4	Tuti Dwi Jayati, Amd. Keb	- Tanggap dan cekatan dalam melakukan manajemen stunting dan wasting - Mampu mengambil keputusan saat menemui masalah	- Tanggap dan cekatan dalam melakukan manajemen stunting dan wasting - Mampu mengambil keputusan saat menemui masalah
5	Nafisah Ulfah Hasanah S. Gz	- Tanggap dan cekatan dalam melakukan manajemen stunting dan wasting - Mampu mengambil keputusan saat menemui masalah - Mampu memberikan Tindakan dan terapi awal pasien stunting dan wasting	- Tanggap dan cekatan dalam melakukan manajemen stunting dan wasting - Mampu mengambil keputusan saat menemui masalah - Mampu memberikan Tindakan dan terapi awal pasien stunting dan wasting

6	Nuraini Radika Rifqi, S. Kep., Ns	Tidak terdapat evaluasi di semester 1, karena mengikuti tim stunting dan wating pada bulan Oktober (semester 2)	- Tanggap dan cekatan dalam melakukan manajemen stunting dan wasting - Mampu mengambil keputusan saat menemui masalah
7	Apt. Pipin Purwa Ningrum, S. Farm	- Tanggap dan cekatan dalam melakukan manajemen stunting dan wasting - Mampu mengambil keputusan saat menemui masalah	- Tanggap dan cekatan dalam melakukan manajemen stunting dan wasting - Mampu mengambil keputusan saat menemui masalah
8	Mike Maulina Sri Hartati S. Kep, Ners	- Tanggap dan cekatan dalam melakukan manajemen stunting dan wasting - Mampu mengambil keputusan saat menemui masalah	- Tanggap dan cekatan dalam melakukan manajemen stunting dan wasting - Mampu mengambil keputusan saat menemui masalah

3.2. Pengembangan Pelayanan

Dilakukan monitoring evaluasi pasien post KRS. Koordinasi dan kunjungan rumah oleh tim stunting dan wasting, ditemani ahli gizi puskesmas dan bidan desa setempat .

3.3. Kinerja Produktifitas Unit dan Instalasi

3.3.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting Tahun 2025

Tabel 3.3.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting Tahun 2025

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	- Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting. - Memberikan edukasi kelompok dengan cara melakukan penyuluhan di ruang tunggu poli spesialis tentang stunting dan wasting. - Melakukan edukasi individu terhadap seluruh pasien rawat inap yang melahirkan, pasien anak, dan keluarga pasien anak tentang pemberian diet seimbang untuk mencegah stunting, serta pemberian edukasi mengenai IMD & ASI Eksklusif. - Pelatihan mengenai Stunting telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2025 dengan peserta seluruh ahli gizi dan kepala ruang di RS Prima Husada Malang
2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husda Malang

4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang
5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan 2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas 3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada, Selain itu tim stunting dan wasting juga mengadakan pemantauan tumbuh kembang balita yang teridentifikasi stunting& wasting saat rawat inap dengan melakukan kunjungan ke rumah pasien tersebut bersama ahli gizi puskesmas, bidan desa, dan kader posyandu.
8	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
9	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap. Pemberian makanan tambahan diberikan saat balita rawat inap lengkap dengan pemberian edukasi tentang cara memenuhi kebutuhan balita untuk mengejar pertumbuhan balita yang tertinggal dengan diet yang tinggi kalori tinggi protein.
10	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
11	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
12	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Terdapat Kerjasama dengan ahli gizi puskesmas, bidan desa, dan kader posyandu dalam pemantauan temuan balita stunting saat dirawat di RSPHM. Kegiatan pendampingan klinis meliputi pengukuran tinggi, berat badan, dan asupan makan balita selama setelah KRS
13	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis

- 1) Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di rumah sakit.
- 2) Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah sakit.

3.3.2 Kinerja Produktivitas

Tabel 3.3.2 Peningkatan efektifitas intervensi gizi spesifik

Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambahan darah dan asam folat	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pemberian Makanan Bayi dan	1. Penyuluhan tentang	IRNA Anak	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Anak (PMBA)	ng stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA														
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pemberian vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian vitamin A	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu	Pasien anak	Rawat Inap	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



	menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan														
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Analisis :

Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Akan tetapi ada beberapa intervensi yang diberikan dengan bekerjasama dengan puskesmas karena ketersediannya hanya ada di puskesmas seperti pemberian bubuk taburia dan vitamin A.

Rencana Tindak Lanjut :

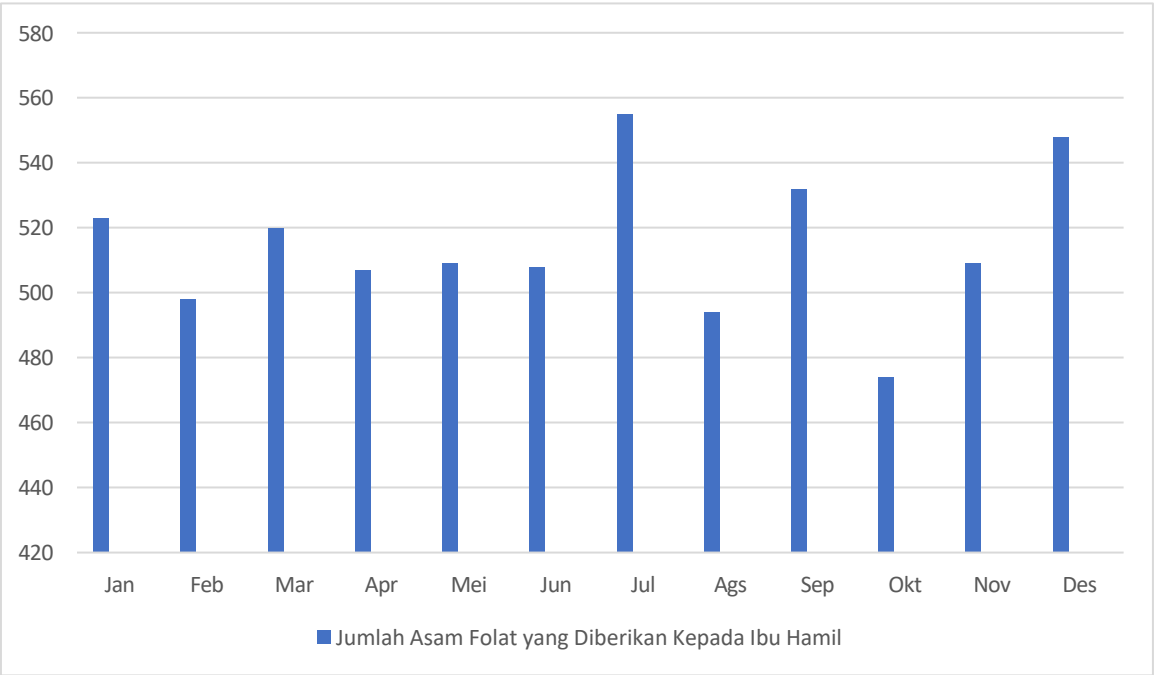
Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.3.3 Pemberian Tablet Besi Folat bagi ibu hamil

Tabel 3.3.3 Distribusi Tablet besi folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	523	498	520	507	509	508	555	494	532	474	509	548

Grafik 3.3.3 Jumlah Pemberian tablet besi folat pada ibu hamil Di RS Prima Husada Tahun 2025



Analisis :

Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah asam folat yang diberikan kepada ibu hamil mengalami naik turun pada tahun 2025 bergantung kepada jumlah kunjungan ibu hamil. Dan capaian paling tinggi terdapat pada bulan Juli, dan capaian terendah terdapat pada bulan Oktober.

Rencana Tindak Lanjut:

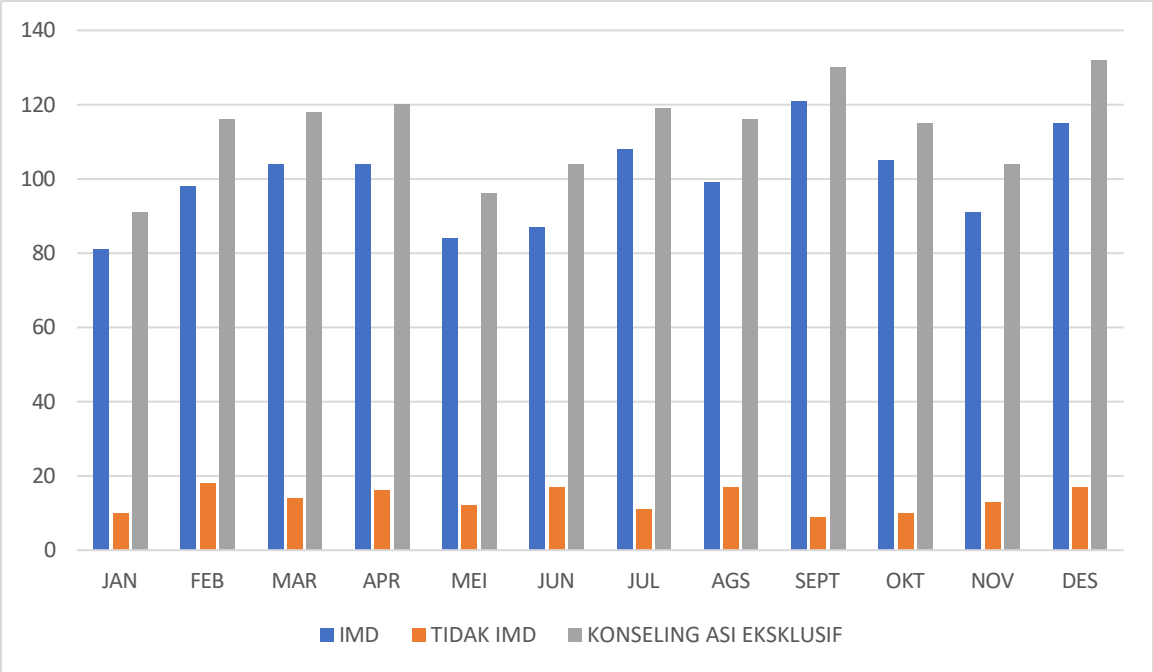
1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.3.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusui Dini dan ASI Eksklusif

Tabel 3.3.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

No	Uraian	Jumlah Pasien											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s
1	IMD	81	98	104	104	84	87	108	99	121	105	91	115
2	Tidak IMD	10	18	14	16	12	17	11	17	9	10	13	17
3	Mendapa t Konselin g ASI Eksklusif	91	116	118	120	96	104	119	116	130	115	104	132

Grafik 3.3.4 Pelayanan IMD dan Konseling ASI Eksklusif di RS Prima Husada Tahun 2025



Analisis :

1. Bayi yang dilakukan IMD, capaian tertinggi di bulan September selama tahun 2025. dan capaian bayi tidak dilakukan IMD paling tinggi pada bulan Februari. Kasus tidak dilakukan IMD hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
2. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
3. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif capaian tertinggi pada bulan Desember 2025.

Rencana Tindak Lanjut:

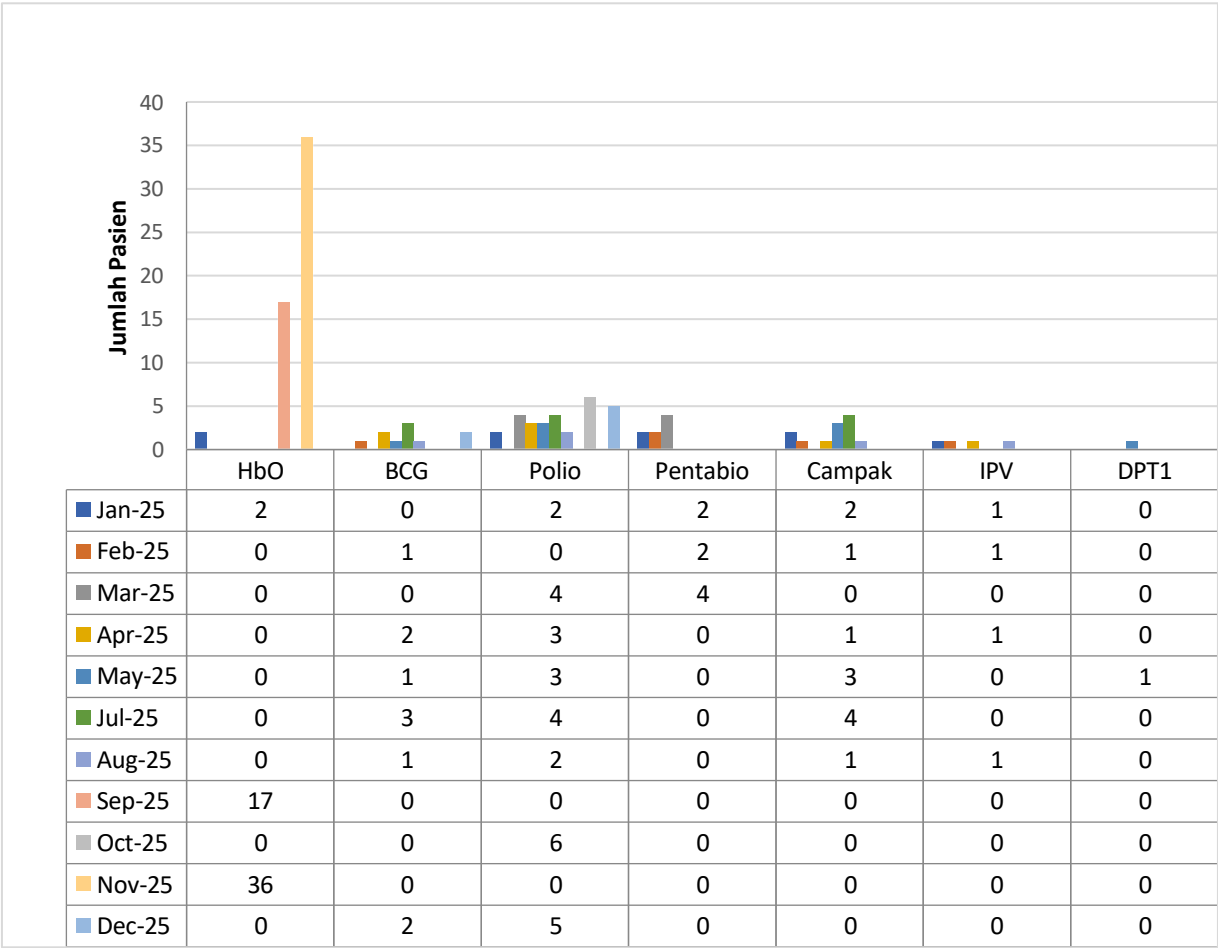
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.3.5 Jumlah Balita yang mendapat imunisasi

Tabel 3.3.5 Jumlah Balita yang mendapat imunisasi

No	Jenis Pelayanan	Jumlah											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s
1	HbO	2	0	0	0	0	0	0	0	17	0	36	0
2	BCG	0	1	0	2	1	2	3	1	0	0	0	2
3	Polio	2	0	4	3	3	4	4	2	0	6	0	5
4	Pentabio	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Campak	2	1	0	1	3	0	4	1	0	0	0	0
6	IPV	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
7	DPT 1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8	DPT 2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
9	DPT 3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0

Grafik 3.3.6 Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025



Analisis:

Kunjungan pasien meningkat pada bulan November, dilakukan imunisasi Hb0. Namun, di bulan bulan lainnya mengalami penurunan dikarenakan jumlah vaksin dari dinas kesehatan yang dikirim ke puskesmas terbatas sehingga tidak bisa di berikan ke RS swasta.

Rencana Tindak Lanjut :

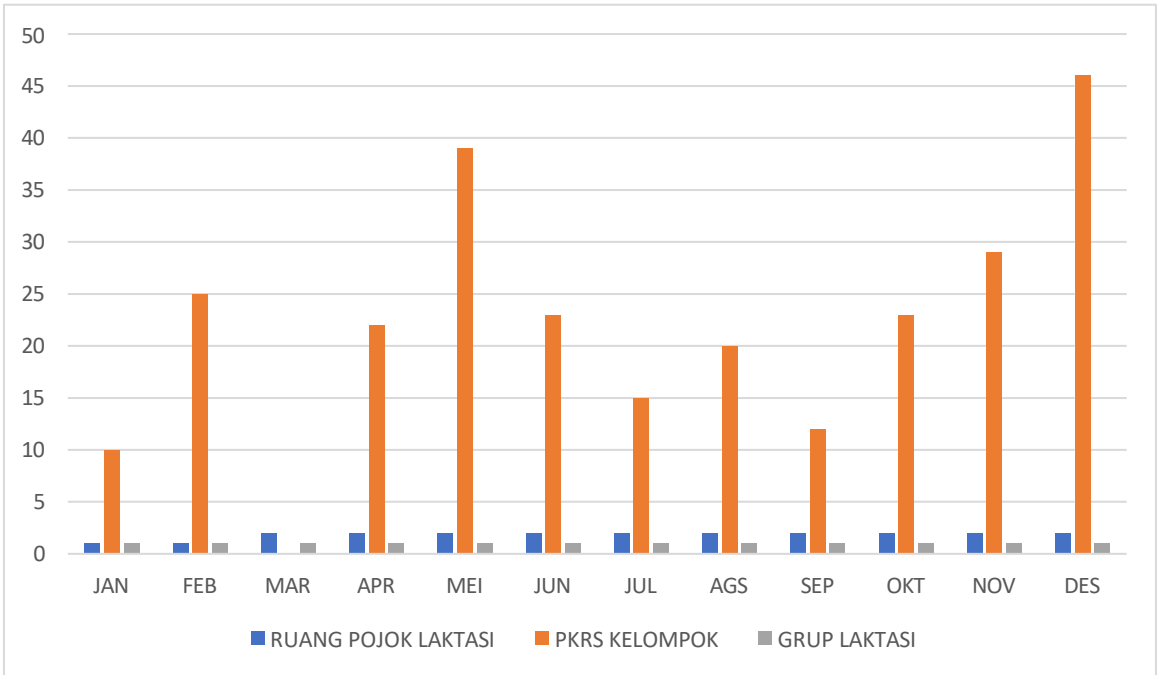
Tim Penanggungjawab Imunisasi melakukan koordinasi dengan pihak Puskesmas Singosari untuk penyediaan vaksin HB0 dan rotavirus di RS Prima Husada Malang.

3.3.6 Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi

Tabel 3.3.6 Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi

Kegiatan Penerapan Rumah sakit sayang ibu dan bayi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Ruang Pojok Laktasi	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Edukasi Ibu Hamil	10	25	0	22	39	23	15	20	12	23	29	46
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Grafik 3.3.6 Senam Hamil Di Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025



Analisis :

1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah rumah sakit prima husada malang. Dan semenjak Maret 2025 RS Prima Husada Malang memiliki 2 ruang pojok laktasi.
2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
3. Edukasi ibu hamil dilakukan di poli obgyn dan senam ibu hamil.

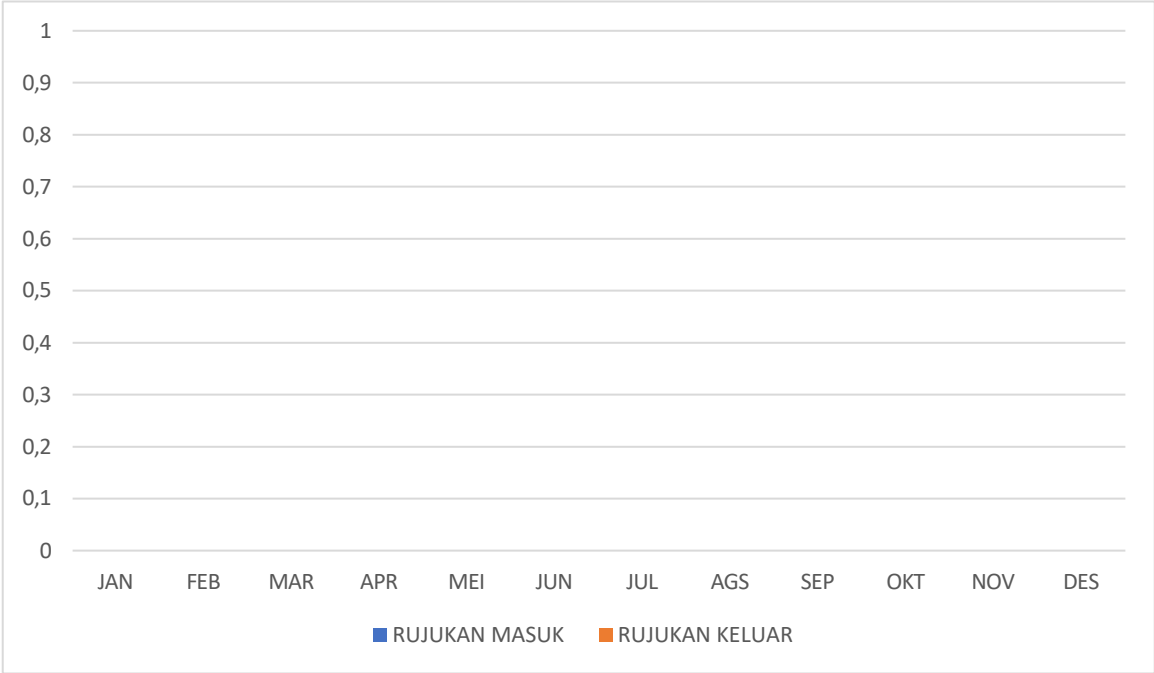
Rencana Tindak Lanjut :

Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti popok dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.

3.3.7 Pelayanan jejaring rujukan kasus stunting dan wasting
Tabel 3.3.7 Layanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting

N o	Rujukan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag s	Se p	Ok t	No v	De s
1	Rujukan Masuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rujukan keluar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grafik 3.3.7 Layanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting



Analisis :
Tidak terdapat balita yang rujuk masuk ke RS Prima Husada Malang ataupun rujuk keluar dari RS Prima Husada Malang.

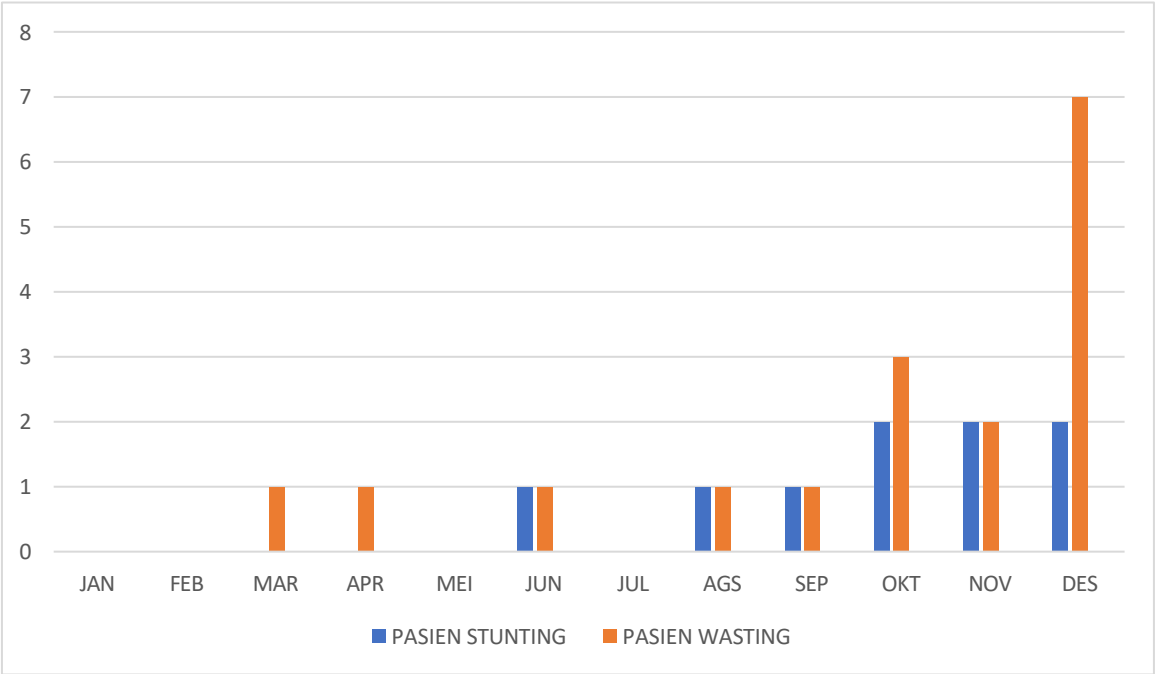
Rencana Tindak Lanjut:
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjejaring pasien stunting dan wasting.

3.3.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

Tabel 3.3.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Pasien Stunting	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	2
Pasien Wasting	0	0	1	1	0	1	0	1	1	3	2	7

Grafik 3.3.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisa :

Terdapat balita terindikasi stunting dan wasting di RS Prima Husada Malang pada bulan Maret, April, Juni, Agustus, September, Okktober, November, dan Desember. Hal tersebut dikarenakan pola makan balita terbilang kurang karena hanya 1-2 kali sehari, pasien juga jarang megkonsumsi makanan tinggi protein dan jumlah asupan makan sekali makan terbilang kurang yaitu 2 sdm tiap makan. Dan memiliki riwayat BBLR dan sakit yang tidak kunjung mereda.

Rencana Tindak Lanjut :

Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada memberikan terapi dengan bekerja sama dengan dokter spesialis anak untuk memberikan diet TKTP, vitamin dan antibiotik yang dibutuhkan untuk mengatasi infeksi yang diderita pasien. Selain itu tim SW juga bekerjasama dengan cara melaporkan pasien stunting kepada petugas Gizi Puskesmas wilayah pasien tinggal untuk melakukan pemantauan lebih lanjut dan pemberian intervensi lanjutan kepada balita stunting dan wasting tersebut.

3.3.9 Program Pemantauan dan Evaluasi

Program pemantauan dan evaluasi yang diberikan kepada pasien stunting dan wasting adalah dengan cara mengontrol pola makan, berat badan dan tinggi badan pasien pada saat pasien melakukan kunjungan kontrol *post KRS*. Kunjungan pasien stunting dan wasting *post KRS*

dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Ahli Gizi puskesmas, Bidan desa, dan kader posyandu untuk memberikan edukasi gizi secara terintegrasi untuk membantu mengontrol asupan makan pasien agar pasien dapat mencapai status gizi yang optimal.

Analisa :

Program pemantauan dan evaluasi pasien stunting yang ditemukan saat rawat inap masih belum terlaksana dikarenakan pasien tersebut tidak melakukan kunjungan kontrol *post KRS*.

Rencana Tindak Lanjut :

Menghubungi petugas gizi untuk melakukan pemantauan berat badan , tinggi badan, dan pola makan pada balita stunting yang ditemukan tim stunting dan wasting RS Prima Husada Malang.

BAB IV.

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1. Ketenagaan Tim Stunting dan Wasting Tahun 2025 belum sesuai kebutuhan yang terlampir di SK dan kebutuhan sesuai stardes.
2. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tim Stunting dan Wasting sudah terlaksana sesuai jadwal, yaitu diklat internal terlaksana 1 kali.
3. Pembinaan jejaring dilakukan 1 kali di tahun 2025 yaitu pada bulan Februari dengan materi Gizi Seimbang yang dilaksanakan di Aula Rumah Yatim Sabilillah dengan pengisi materi Chandrawati Mustikasi S. Tr. Gz.
4. Beberapa vaksin terbatas ketersediannya dan ketersediannya hanya ada di puskesmas.
5. Perlu ditingkatkan koordinasi dari faskes pertama, untuk meningkatkan jejaring rujukan balita stunting dan wasting.
6. Ketersediaan hanya ada di puskesmas seperti pemberian bubuk taburia dan vitamin A, perlu adanya kolaborasi dengan faskes pertama.

1.2 Saran

1. Pengajuan ke Tim Akreditasi RS Prima Husada Malang untuk pemenuhan kebutuhan Tim Stunting dan Wasting sesuai stardes
2. Sasaran diklat stunting lebih diperluas agar tidak hanya perwakilan saja.
3. Meningkatkan pembinaan jejaring lebih diaktifkan dengan melakukan kerja sama lintas sektor.
4. Koordinasi dengan faskes pertama untuk peningkatan jejaring rujukan, ketersediaan vaksin, serta pemberian bubuk taburia dan vitamin A.

BAB V

PENUTUP

Demikian laporan tahun 2025 Tim Stunting dan Wasting disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Malang tahun 2025. Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang perbaikan pelayanan di tahun berikutnya

Malang, 08 Januari 2025

Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Nur Mazidah